

Встановлення орофарингеального повітряпроводу

Сценарій

Ви – лікар з медицини невідкладних станів, в складі бригади екстреної медичної допомоги прибули на виклик. Людина на зупинці автотранспорту раптом знепритомніла. Постраждалий лежить на спині, дихання відсутнє, пульс не визначається, шкіра ціанотична, зіниці широкі, на світло не реагують. Ви приступаєте до відновлення прохідності дихальних шляхів, а саме встановити орофарингіального повітряпроводу.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує приміщення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен для інтубації трахеї	1 шт.
6	Орофарингеальний повітровід (різних розмірів)	1 шт.
7	Мішок Амбу	1 шт.
8	Каремат чи ковдра під манекен	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Орофарингеальний повітровід (різних розмірів)	1 шт.
2	Мішок Амбу з лицьовою маскою	1 шт.



Орофарингеальний повітровід

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановлення контакту з людьми які намагались надати допомогу (привітатись, представитися, позначити свою роль). Відповідь на питання лікаря до людей надає екзаменатор.	<i>Сказати</i> Доброго дня. Я лікар з медицини невідкладних станів, що тут сталося? Скільки минуло часу з моменту як постраждалий знепритомнів?.

		<i>Відповідь:</i> Це трапилось близько 5 хвилин назад, він втратив свідомість.
1.2	Одягнути медичні рукавички	<i>Виконати</i>
2.Виконання навички		
2.1	Помістити пацієнта в горизонтальне положення на спині або на ношах з невеликим нахилом.	<i>Виконати</i>
2.2	При необхідності очистити ротоглотку від виділень, блювотних мас або сторонніх предметів	<i>Виконати</i>
2.3	Визначити відповідний розмір ротоглоткового повітропроводу для цього необхідно утримувати повітропровід біля щоки пацієнта з фланцем у кутку рота. Кінець повітропроводу відповідного розміру повинен доходити до кута нижньої щелепи.	<i>Виконати</i>
2.4	Після вибору повітря воду починаємо вводити повітропровід у рот, розгорнувши загострений кінець до неба (тобто увігнутою стороною вгору).	<i>Виконати</i>
2.5	При введенні повітропроводу необхідно бути обережними, щоб не порізати губи та не защемити їх між зубами та повітропроводом	<i>Виконати</i>
2.6	Повертаємо повітропровід на 180 градусів у міру просування в задній ротоглотці. Цей метод запобігає виштовхуванню повітропроводу язиком назад під час введення та подальшій обструкції дихальних шляхів.	<i>Виконати</i>
2.7	При повному встановленні фланець пристрою повинен розташовуватися на губах пацієнта	<i>Виконувати</i>
2.8	В якості альтернативи при введенні повітропроводу кінцем, спрямованим в напрямку до дна ротової порожнини (тобто увігнутою стороною вниз) потрібно використовувати шпатель для притискання язика. Використання шпателя не дозволяє повітропроводу під час введення відтиснути язик назад.	<i>Виконати</i>
3. Встановити попередній діагноз (визначити стан пацієнта)		
3.1	Стан клінічної смерті	<i>Сказати</i>
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після встановлення повітряводу почати штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця, та як найшвидше доправити до спеціалізованого закладу	<i>Сказати</i>

